Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE APOIO AS REDES REGIONAIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARAS

Nº Carta Consulta: 61202
Processo: 03101.002106/2024-83
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 30 de Julho de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 113.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 230.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 13
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 15
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 15
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 16
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 16
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de São Paulo é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Localizado no sudeste brasileiro, possui apenas 3% do território nacional, mas conta com 44.411.238 milhões de habitantes (último censo [2022] - IBGE), que representam cerca de 21% da população do país, constituindo-se na terceira unidade administrativa mais populosa da América do Sul.

Responsável por mais de 32,2% do PIB do país, São Paulo abriga o maior parque industrial e a maior produção econômica e figura entre os estados brasileiros com maior Índice de Desenvolvimento Humano - 0,806 (IBGE 2022), sendo superado apenas pelo Distrito Federal, embora ainda mantenha grandes desigualdades socioeconômicas regionais e concentrações de pobreza em seu território, como as regiões do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Itapeva que possuem municípios com IDH que chegam a 0,639 (Ribeirão Branco). Da mesma forma que em outras unidades federadas, as diferenças regionais ou de base territorial supra municipal afetam ainda o conjunto de resultados, e permitem inferir barreiras e problemas no acesso dos serviços de saúde pela população.

Também é importante destacar que apesar dos avanços das últimas duas décadas, ainda são grandes as barreiras de acesso ao SUS para certas populações, historicamente excluídas, como população negra (principalmente mulheres), quilombolas, indígenas e população privada de liberdade (prisões).

Para esta Carta-Consulta foi priorizado o tema da regionalização, e da inovação e tecnologia em saúde, visando uma mudança de paradigma, no qual estabelece-se o compromisso de um ?governo único para cidadão único?, através da democratização do acesso à assistência e a informação e o desenvolvimento e prestação de serviços públicos integrados, com foco no cidadão, ao invés de foco no sistema.

O Projeto a luz da experiência exitosa do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde - Programa Saúde em Ação, visa dar continuidade as ações de consolidação e fortalecimento das redes regionais de atenção à saúde - RRAS, expandindo para outras áreas do estado que não foram beneficiadas na primeira operação de crédito do BID, investimentos para a articulação e coordenação do cuidado a partir da integração entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada.

No Estado de São Paulo, as Doenças e Agravos não Transmissíveis - DANT continuam como as principais causas de morte, sendo nas últimas décadas as mais prevalentes e as que mais geram custos para o sistema de saúde, mesmo sendo, em grande parte, um grupo de doenças passíveis de prevenção. Anexos I e II

Apesar da grande Rede de Serviços no estado, são constatados problemas organizacionais que prejudicam a cobertura da rede, como a falta de integração entre os serviços hospitalares e os demais níveis assistenciais ? especialmente atenção básica, com fragmentação dos cuidados assistenciais, dificuldades no acompanhamento dos casos crônicos, incapacidade de atuação adequada por falta de padronização, linhas de cuidados e protocolos de atendimento, que se implantados, poderiam reduzir internações desnecessárias e ampliar as vagas para os casos de urgência e emergência, bem como os casos cirúrgicos eletivos. E também com uma estrutura de Serviços antiga e que já não atende adequadamente às novas necessidades assistenciais do SUS e as mudanças ambientais e climáticas observadas atualmente..

Ao se avaliar o contingente populacional, São Paulo enquanto Estado, assume a primeira colocação como Estado mais populoso, com um contingente de 46.649.132 habitantes, que corresponde à quase ¼ da população brasileira, que até 2021, era de 213.317.639 habitantes (IBGE, 2021).

Partindo do princípio de que tanto o Brasil quanto o Estado de São Paulo possuem diversos municípios com uma população pequena, com grandes desigualdades no desenvolvimento socio econômico, com regiões de pobreza e extrema pobreza e consequentemente com maior dificuldade de contar com a estruturação de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) que supra todas as necessidades de saúde de sua população, entende-se que para alcançar escala, racionalização e eficiência dos recursos o processo de regionalização é o caminho para resolução desses problemas.

O Estado de São Paulo é dividido em 18 macrorregiões de saúde (Redes Regionais de Atenção a Saúde ? RRAS) e 62 regiões de saúde.

Devido ao alto grau de desigualdade no acesso aos Serviços de Saúde, índices de pobreza e às lacunas assistenciais encontradas nos territórios das RRAS de 1 a 6, RRAS 8 e RRAS 12, identificados no processo de regionalização e a excessiva demanda provocada pelo alto grau de atração da RRAS 6 essas regiões foram priorizadas pelo Projeto ARAS. Em relação às RRAS 8 e RRAS 12, principalmente nas regiões de Itapetininga e Consórcio do DRS II.

Anexos III ao XXI

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo - ARAS SP é um conjunto de investimentos que visa o fortalecimento da ação do SUS em São Paulo, prevendo a melhoria na oferta de serviços essenciais para as regiões mais pobres e vulneráveis do Estado, nas quais ainda persistem problemas de acesso e qualidade do SUS. O Projeto a luz da experiência exitosa do Programa Saúde em Ação visa dar continuidade as ações de consolidação e fortalecimento das redes regionais de atenção a saúde - RRAS, expandindo para outras áreas do estado que não foram beneficiadas na primeira operação de crédito do BID, investimentos para a articulação e coordenação do cuidado a partir da integração entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada.

Será utilizado como eixo central do Projeto ARAS SP, o processo de Regionalização no Estado de São Paulo, que será o ponto de partida para pensarmos a redefinição do perfil assistencial das unidades que compõem as redes de atenção à saúde, para dessa forma, equalizar o acesso e qualidade dos serviços no Estado de São Paulo e organizar a atenção à saúde de forma racionalizada e eficiente. É importante ressaltar que o Estado está fazendo um grande trabalho com os gestores nas regiões, com escuta qualificada, o que garantiu um processo de regionalização representativo e que têm corroborado com os dados aqui apresentados. Este investimento na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) que inclui as RRAS de 01 a 06 (especialmente na RRAS 6) e nas RRAS 8 e RRAS 12, representará uma resposta do Estado às necessidades e dificuldades destas regiões. Haverá a construção dos dois novos hospitais nas RRAS 8 e RRAS 12 e um grande investimento de adequação e inovação do parque tecnológico nas unidades da Região Metropolitana de São Paulo , onde concentram-se as maiores desigualdades sociais no Estado, e visando também reduzir os impactos ambientais e aumentar a eficiência energética, hídrica e resiliência dos equipamentos de saúde frente aos atuais eventos de cambio climático.

Além do apoio metodológico para a elaboração dos Planos Regionais Integrados, melhorando a organização da rede e a governança regional, que serão fundamentais para o sucesso da regionalização no Estado, ampliando o acesso e qualificando a assistência.

O projeto também busca contribuir para a agenda de inovação em saúde, a partir do financiamento de novas tecnologias da estratégia de Saúde Digital, com o investimento em infraestrutura em tecnologia da informação e modernização dos equipamentos nos 15 Hospitais da administração direta contemplados no presente projeto, bem como modernização e aquisição de servidores, storage e segurança de dados no nível central da SES, possibilitando a recepção das novas tecnologias, incluindo a telemedicina e informatização das unidades para utilização de ferramentas de gestão.

Com a adequação na estrutura das Unidades existentes e atualização de um parque tecnológico já obsoleto e ineficiente, assim como a construção de 2 novos Hospitais, o resultado almejado é uma ampliação no acesso à diagnósticos e tratamentos as principais causas de morbimortalidade identificadas nas diversas regiões do estado. E com as ações propostas para o apoio à gestão, busca-se a constituição de regiões potentes, com uma governança eficiente na avaliação e monitoramento dos contratos e prestação de serviços, com vistas a um planejamento integral que traga autonomia para a região e linhas de cuidado / protocolos efetivamente implantados para uma assistência oportuna e qualificada.

O projeto reforçará os compromissos do Estado de São Paulo quanto à melhoria de acesso à saúde das populações vulneráveis e minorias (Objetivo 5, Plano Estadual de Saúde- PES), por meio da expansão de serviços nas regiões com alta concentração de aldeias, quilombolas (DRS Sorocaba) e população preta/parda, principalmente jovens, concentrados na DRS Grande São Paulo. Ao mesmo tempo , expandirá exponencialmente os serviços de telemedicina para a população privada de liberdade, também alinhado com o mesmo objetivo do PES.

As ações propostas trazem, em si, um componente de sustentabilidade após o projeto, tendo em vista que, são impulsionadoras, pois são ações de fortalecimento de políticas públicas estabelecidas, e que, portanto, podem ser executadas com fontes de recurso próprias, uma vez superados os custos iniciais de implantação.

Todos os gastos correntes decorrentes de novos serviços estão afiançados pelos instrumentos de planejamento e orçamento, coordenados pelas Secretarias Estaduais de Fazenda e de Planejamento, como o PPA e Lei Orçamentária Anual. Como parte importante dos investimentos do programa visa melhorar a performance e a eficiência de serviços já existentes, estes já constam na programação orçamentária da SES SP.

No Plano Plurianual (PPA) de 2024-2027, o Programa 930: Atendimento Integrado e Regionalizado no SUS no Estado de São Paulo, contempla as entregas necessárias à garantia do acesso mais rápido do usuário a uma Rede Integrada de Serviços dentro de sua região. Desenvolvendo e implantando políticas públicas robustas e prestando todo o apoio técnico e financeiro aos municípios do estado, com o objetivo de fortalecer a rede de governança e ampliar os serviços à toda população.

Todas as ações financiadas pelo projeto serão informadas e pactuadas em CIR (Comissão Intergestores Regionais), compostas pelos Secretários Municipais de Saúde e representantes da administração regional da SES, em funcionamento em todas as regiões de saúde.

Outro ponto que contribuirá para a sustentabilidade das ações é o investimento no fortalecimento da gestão pública. Estão previstos a aquisição de novas tecnologias e o desenvolvimento de sistemas de informação, que se tornarão um ganho perene para a Administração Pública Estadual. Da mesma forma, a contratação de consultorias e capacitações para os servidores públicos estaduais e municipais permitirá a transferência de conhecimentos, habilidades e competências que serão incorporados ao repertório organizacional mesmo com o encerramento do financiamento.

Não haverá transferência de equipamentos para a gestão municipal, e o processo de regionalização em curso, já conta com a adesão de todos os Municipios, através de um compromisso formalmente assinado por ocasião da constituição de Comitês Executivos de Governança em todas as RRAS. Documentos em anexo

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O SUS é o maior e mais duradouro programa social do país e ampliou enormemente o acesso da população, aos serviços de saúde, embora com resultados diferentes em cada região, mesmo enfrentando um contexto de dificuldades, relacionadas com a realidade econômica e social do país, com o baixo poder aquisitivo da população e com recursos insuficientes ao sistema. Ainda mais se considerarmos a demanda sempre crescente, por uma ampliação tecnológica e assistencial.

Contudo o SUS ainda carece de aperfeiçoamentos estruturais e de gestão para garantir o atendimento universal e integral da população, conforme as diretrizes constitucionais. O Estado de São Paulo, que possui a maior e mais complexa rede de saúde do Brasil, apresenta as melhores condições para que o SUS se aproxime cada vez mais de seus principais objetivos. Para tanto, necessita aperfeiçoar as suas redes de atenção, regulação, integração de serviços e realização de investimentos para corrigir déficits regionais porventura existentes.

O aperfeiçoamento e o sucesso no desenvolvimento do SUS/SP será exemplo para todo o país e trará o reconhecimento de que o atendimento das necessidades de saúde dos cidadãos é fundamental, não apenas para beneficiar a qualidade de vida individual, mas também como insumo imprescindível para o desenvolvimento sustentável da Nação.

Ao longo das últimas décadas, o estado de São Paulo vem atuando fortemente no aperfeiçoamento do SUS/SP, ampliando e modernizando sua rede de serviços próprios e transferindo recursos para os Municípios investirem em seus equipamentos de saúde. Além de investimentos na infraestrutura, vem aprimorando os mecanismos de gestão, articuladamente com os gestores municipais. Estas iniciativas e ações estão traduzidas no Plano Plurianual

As ações propostas no Programa de apoio à regionalização, fortalecimento da gestão e impulso à transformação digital na Saúde do estado de São Paulo estão alinhadas com o Plano Estadual de Saúde (PES), com o Plano Plurianual (PPA), com o Plano Diretor de Regionalização (PDR), assim como com as Politicas Públicas do Ministério da Saúde.

https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/documentos-de-planejamento-em-saude/instrumentos-de-planejamento-do-sus-quadrienio-2024-a-2027/

Valor Financeiro da Contrapartida: US$ 113.000.000,00, relativas a construção e investimentos em infraestrutura de duas novas unidades hospitalares no Estado em Birigui e Itapetininga. No caso dos processos de gestão e regionalização, o estado está desenvolvendo, a partir de recursos próprios e em parceria com projeto do PROADI SUS, diagnóstico nos territórios que serão utilizados aqui como referência. Os gastos estão em conformidade com as resoluções da COFIEX.

USD 1,00 = R$ 5,4

Valores de venda do dólar em 03 de julho de 2024.

2. Projeto

2.1. Título
PROJETO DE APOIO AS REDES REGIONAIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARAS

2.2. Título Abreviado
PROJETO ARAS SP

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL:

Contribuir para melhorar as condições de saúde da população do Estado de São Paulo, por meio da estratégia de regionalização, visando a consolidação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) e o fortalecimento da capacidade de gestão da saúde por parte do estado. Os principais beneficiários do Projeto serão aproximadamente 27 milhões de habitantes SUS dependentes (60% da população geral) para o cuidado à saúde que serão impactadas pelo fortalecimento das RAS, nas RRAS, resultante da implementação de sistemas de apoio à gestão, como novas tecnologias, programações regionais integradas e linhas de cuidado a partir das análises de situação de saúde locais, assim como os investimentos na infraestrutura nos territórios mais vulneráveis através de construções e melhorias nas unidades de saúde estaduais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)Trabalhar a redefinição do perfil assistencial das unidades que compõem as redes de atenção à saúde através das oficinas locais do processo de regionalização, buscando equalizar o acesso e a qualidade dos serviços no Estado de São Paulo;

2)Apoiar metodologicamente a elaboração dos Planos Regionais Integrados para aprimorar a organização da rede e a governança regional, ampliando o acesso e qualificando a assistência;

3)Implementar o Plano Diretor de Educação Permanente, resgatando o papel dos Centros Formadores para profissionais da saúde (CEFOR), e dos Centros de Desenvolvimento e Qualificação (CDQ) para o SUS.

4)Modernizar equipamentos e infraestrutura na perspectiva de novas tecnologias para a saúde digital;

5)Melhorar a eficiência do gasto e a qualidade dos Serviços Assistenciais (protocolos diagnóstico-terapêuticos com a lógica da Medicina Baseada em Evidências, humanização, redução de procedimentos desnecessários, tempestividade do diagnóstico, continuidade assistencial), integrando os diferentes níveis de atenção e garantindo um acompanhamento mais eficiente e completo dos pacientes nas Linhas de Cuidado priorizadas pelo processo de regionalização;

6)Consolidar a área de análise de grandes bancos de dados para fortalecer a gestão populacional de saúde, seguindo as melhores práticas do setor, buscando aprimorar os indicadores epidemiológicos e acompanhamento e monitoramento de programas e políticas de saúde;

7)Investir em novas tecnologias, como a telemedicina, tecnologias POC e a informatização das unidades, para aprimorar a gestão e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Aumentar a qualidade da atenção em saúde;

8)Investir na modernização, infraestrutura e tecnologia dos hospitais das RRAS 1 a 6, visando melhorar os resultados assistenciais e a eficiência no uso do recurso público, assim como adequar estas estruturas hospitalares para consolidar uma rede preparada para futuros desastres decorrentes de eventos climáticos extremos;

9)Construir novos hospitais nas RRAS 8 e 12 para suprir a carência assistencial, agilizando o atendimento, especialmente para condições crônicas, de acordo com o diagnóstico já realizado no processo de regionalização;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de novos leitos SUS instalados nas RRAS 8 e 12	Número total de leitos SUS atual + Leitos Novos	Número de leitos	6.864,00	7.363,00
Média mensal de pacientes atendidos nos novos leitos instalados nas RRAS 8 e 12	Número de novos leitos (499) x giro de leitos (4,0)	Número de pacientes	0,00	1.996,00
Número de atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizado pelas unidades gerenciadas pelas OSS*	Soma de procedimentos de elenco específico dos Hospitais gerenciados por OSS	Número de procedimentos	10.299.244,00	12.200.000,00
Número de atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizados pela administração direta e autarquias*	Soma do número de procedimentos de elenco específico dos Hospitais da Adm direta e Autarquias	Número de Procedimentos	9.001.292,00	11.027.000,00
Média de dias de permanência institucional dos hospitais gerenciados pela adm. Direta e Autarquias*	É a relação entre o número de pacientes dia e o número de saídas. Mede o tempo médio que o paciente permanece internado.	dias	8,26	6,80
Média de dias de permanência institucional dos hospitais gerenciados por OSS*	É a relação entre o número de pacientes dia e o número de saídas. Mede o tempo médio que o paciente permanece internado.	dias	5,04	4,50
Percentual de Internações por Condições Sensíveis a Atenção Básica	% internações por CSAB: % de internações por causas sensíveis à atenção básica no total de internações - Portaria 221, 17/04/ 2008/MS/SAS.	%	14,69	13,00
Número de Planos Regionais Integrados elaborados	Somatória	Número de Planos	0,00	18,00
Número de Linhas de Cuidado implantadas	Somatória	Número de LC	0,00	90,00
Número de aplicações de tecnologia sustentadas no âmbito da secretaria de estado da saúde*	Mensura a sustentação de soluções já implementadas	Unidade	0,00	45,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	**9.000.000,00**
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS	7.500.000,00
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização	2.500.000,00
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica	2.500.000,00
P - Modelos de governança inovadores	2.500.000,00
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA	1.500.000,00
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos	1.500.000,00
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	**185.000.000,00**
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS	185.000.000,00
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS	36.924.519,71
P - REformas das UNidades da Administração Direta	59.512.962,96
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS	50.565.752,72
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta	37.996.764,61
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL	**30.000.000,00**
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE	30.000.000,00
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta	20.000.000,00
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde	10.000.000,00
C - C.4GESTÃO DO PROJETO	**6.000.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	6.000.000,00
P - UGP implantada	6.000.000,00
Total dos Componentes	**230.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Este componente visa apoiar a melhoria da capacidade da SES em seu papel estratégico, indutor e gerencial para a operação eficiente das RAS em São Paulo. Para os Processos de Apoio à Gestão Estadual para o processo de Regionalização das RRAS serão realizadas consultorias, contratos, capacitações.

S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS

Este subcomponente tem como produto realizar consultorias para Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização e promover parcerias com universidades para formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica.

P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização

Este subcomponente tem como produto realizar consultorias para Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização e promover parcerias com universidades para formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica

P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica

Parcerias com Universidades para formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica

P - Modelos de governança inovadores

Serão realizados estudos nas macro regiões para identificação de fragilidades e potencialidades nos modelos atuais de governança regional e para a definição de modelos que atendam a todas as especificidades das Macro regiões de Saúde, tendo o estado o papel estratégico indutor e coordenador efetivo deste processo.

S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA

Este subcomponente tem como produto o desenvolvimento de oficinas do processo de regionalização do SUS SP e o fortalecimento dos atores para realização do diagnóstico situacional estadual.

P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos

Realização de Oficinas Macro regionais para discussão do Plano Regional Integrado, da Programação Assistencial e para a construção do Pacto pela Saúde de São Paulo.

C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Este componente deverá priorizar as reformas e as inovações do parque tecnológico das unidades da SES envolvidas no projeto ARAS; RRAS 1 a 6, RRAS 8 e RRAS 12.

S.2.1Melhorias na Infraestrutura da Rede de Serviços Estaduais
P.2.1.1Reforma dos Hospitais da Administração Direta
P.2.1.2Reforma dos Hospitais sob gestão das OSS
P.2.1.3Equipagem dos Hospitais da Administração Direta
P.2.1.4Equipagem dos Hospitais sob gestão das OSS

S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS

Este subcomponente tem como produto realizar a Reforma dos Hospitais da Administração Direta, Reforma dos Hospitais de OSS, Equipagem dos Hospitais da Administração Direta e Equipagem dos Hospitais da Administração Direta.

P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS
Reformas de 18 Unidades Hospitalares próprias estaduais sob gerenciamento de OSS.

P - REformas das UNidades da Administração Direta
Reformas de 12 Hospitais estaduais da Administração Direta.

P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS
Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS

P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta
Atualização do Parque Tecnológico das Unidades Estaduais da Administração Direta

C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL
S.C.3.1 Melhoria da Tecnolgia em Saúde
Este subcomponente tem como produto prover as Unidades Hospitalares, da Administração Direta com equipamentos de TI permitindo a inovação na área de saúde digital. Os investimentos neste componente III do projeto atingem o valor de US$ 30 milhões de dólares.

S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE
Este subcomponente tem como produto prover as Unidades Hospitalares, da Administração Direta, bem como do datacenter da Secretaria de estado da Saúde, com infraestrutura para TI permitindo a inovação na área de saúde digital.

P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta
Prover de Infraestrutura em TI os Hospitais da Administração Direta contemplados neste projeto, para a promoção ao uso de novas tecnologias, como telemedicina, prontuário eletrônico e outros.

P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde
Prover de infra estrutura de TI (Servidores, Storage, Segurança da Informação, o Datacenter da Secretaria de estado da Saúde - Nível Central, permitindo a capacidade para a absorção de novas tecnologias na saúde digital.

C - C.4GESTÃO DO PROJETO

Implantação de Unidade de Coordenação do Programa para a gestão dos projetos e monitoramento das obras

S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
Este subcomponente tem como produto implantação de Unidade de Coordenação do Projeto para a gestão dos componentes .

P - UGP implantada
A UGP deverá apoiar a SES na execução efetiva do Projeto, responsável pelo gerenciamento efetivo das atividades planejadas e do monitoramento dos resultados , além de suprir as despesas operacionais como passagens, hospedagens, etc. .

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**96.437.482,67**	**41,93**
P- Reformas das Unidades gerenciadas por OSS	Numero Absoluto	18,00	36.924.519,71	16,05
P- REformas das UNidades da Administração Direta	Numero Absoluto	12,00	59.512.962,96	25,88
Bens	-	-	**118.562.517,33**	**51,55**
P- Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS	Numero Absoluto	22,00	50.565.752,72	21,99
P- Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta	Numero Absoluto	15,00	37.996.764,61	16,52
P- Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta	Numero Absoluto	15,00	20.000.000,00	8,70
P- Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde	Numero Absoluto	1,00	10.000.000,00	4,35
Consultoria	-	-	**5.000.000,00**	**2,17**
P- Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização	Numero Absoluto	10,00	2.500.000,00	1,09
P- Modelos de governança inovadores	Numero absoluto	18,00	2.500.000,00	1,09
Capacitação e Treinamento	-	-	**2.500.000,00**	**1,09**
P- Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica	Numero Absoluto	2.000,00	2.500.000,00	1,09
Outros	-	-	**7.500.000,00**	**3,26**
P- Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos	Numero Absoluto	100,00	1.500.000,00	0,65
P- UGP implantada	Numero Absoluto	1,00	6.000.000,00	2,61
Total Geral	-	-	**230.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Programa de Fortalecimento da Gestão da Saúde no estado de São Paulo -Saúde em Ação, cofinanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, iniciado em 2014 com término em 2021, evidenciou a necessidade urgente de investimentos no setor de tecnologia, buscando a inovação nas práticas gerenciais e assistenciais no SUS.

A concepção do Programa foi uma resposta ao perfil epidemiológico do estado em que as três principais causas de mortalidade na última década foram doenças cardiovasculares, neoplasias e patologias do sistema respiratório.

O Fortalecimento da gestão na SES foi contemplado com ações específicas, como o desenvolvimento dos Planos Diretores da Assistência Farmacêutica e da Educação Permanente, oferecendo estudos com vasto diagnóstico dos temas e diretrizes a serem perseguidas para o melhor desempenho nestas áreas. E um estudo para a Elaboração do Diagnóstico e Avaliação do Estágio de Desenvolvimento das Redes Regionais da Atenção à Saúde nas Regiões Priorizadas pelo programa.

Naquele momento cinco regiões do estado foram selecionadas para participar do Programa ‐ Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Jurumirim, Litoral Norte e Campinas ‐ abrangendo ao todo 71 municípios paulistas, e 10% da população do estado de São Paulo, por serem consideradas as mais vulneráveis, com indicadores de saúde preocupantes e dificuldades de acesso à assistência na saúde.

Em cada região, as ações do Projeto foram desenvolvidas levando em consideração o perfil epidemiológico e os desafios da gestão da saúde local. Assim, apesar da unicidade dos objetivos gerais do Projeto, cada região participante foi afetada de maneira diferente, com ações customizadas para a realidade local.

Dando continuidade ao Programa Saúde em Ação, o Projeto ARAS, com investimentos em todo o estado e particularmente em nas regiões indentificadas como prioritárias no momento, deverá envolver oficinas de trabalho, consultorias e treinamentos, especialmente voltados à Gestão Regional, ou ao que chamamos de Regionalização na saúde.

Em 2023 iniciou-se um processo para a estruturação e qualificação de estratégias de gestão com foco no processo de Regionalização da Saúde no Estado de São Paulo.

Ao final de um ano, com 2 rodadas de oficinas realizadas em todas as regiões, observamos que os temas mais sensíveis priorizados por todas as regiões são: Cardiologia, Oncologia e Saúde Mental e que uma das principais questões a serem discutidas e trabalhadas regionalmente seriam a qualificação e a implementação de ações de saúde para fortalecer a governança e a resolutividade da gestão do SUS no estado de São Paulo, além dos investimentos em tecnologia e adequada infraestrutura nas regiões que se apresentam carentes de recursos.

Neste mesmo período foi celebrado um Termo de Cooperação mutuo entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Gestão e Governo Digital de São Paulo, que teve por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes para a efetiva execução do Componente 4 ? Saúde Digital do Projeto São Paulo Mais Digital, nos produtos em que a SES será beneficiária, conforme descrito no Contrato de Empréstimo nº 5579/OC-BR.

Consultar anexo "Informações atualizadas sobre os Hospitais de Itapetininga e Birigui"

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de São Paulo ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: 60 meses (5 anos);

Prazo de carência: 60 meses (5 anos);

Prazo de amortização: 228 meses (19 anos);

Prazo total: 288 meses (24 anos);

Periodicidade da amortização: Semestral;

Taxa de juros: SOFR (5,39% em 03/07/2024) + spread variável (atualmente 0,8%) + Funding margin (atualmente 0,4%);

Demais encargos do financiamento:

- Comissão de Crédito: Até 0,75% ao ano sobre o saldo não desembolsado do Empréstimo.

- Despesas de Inspeção e Supervisão: até 1% do valor do empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

A busca por financiamento externo para o projeto decorre de várias considerações estratégicas e econômicas. Em primeiro lugar, o custo dos empréstimos nacionais é mais alto do que os empréstimos internacionais, conforme exposto adiante na comparação entre agentes financeiros. Ainda, algumas entidades nacionais, como o BNDES, exigem um índice mínimo de nacionalização dos itens adquiridos com recursos do financiamento, o que pode não ser viável no presente projeto, que apresenta em um de seus componentes a aquisição de aparelhos de diagnóstico e tratamento de alta tecnologia que muitas vezes não tem produção nacional. Além disso, a captação de recursos de instituições internacionais apresenta-se como uma alternativa valiosa, uma vez que tais entidades oferecem não apenas recursos financeiros, mas também expertise técnica e padrões rigorosos de governança, socioambientais e de desempenho. de modo a conferir uma credibilidade adicional ao projeto, reforçando seu compromisso com elevados padrões de qualidade e responsabilidade socioambiental. Portanto, a opção por financiamento externo, especialmente de entidades internacionais de renome, se mostra como uma estratégia sólida e vantajosa para impulsionar o êxito e a sustentabilidade do projeto, além de se configurar como uma alternativa mais barata.

(b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A escolha do BID como agente financeiro para o decorre de uma série de fatores, dentre eles, o fato de apresentar as taxas mais baixas, conforme demonstrativo juntado nos anexos. O BID conta também a seu favor com uma experiência positiva em projetos na área de saúde no Brasil, em especial com São Paulo, devido ao exitoso projeto de Fortalecimento da Gestão de Saúde. Ainda, o Estado de São Paulo tem um bom histórico de relacionamento com o BID, contando com seu apoio em diversos projetos nas mais diversas áreas. Por já ter essa experiência prévia com o agente financeiro, o proponente tem conhecimento das normas de licitação do Banco bem como de outros aspectos operacionais de forma a facilitar o relacionamento do executor com a instituição financeira quanto a estes termos.

(c) Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto, foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que o BID oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais bancos:

BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread vigente é de 1,65% a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso sob o saldo não desembolsado de 0 ,25% a.a.;

BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,2% a.a. (prazo médio máximo de 15,25). Encargos: Comissão de compromisso de até 0,75% a.a. sob o saldo não desembolsado;

NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread mais recente disponível é de 1,6% a.a.. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sob o saldo não desembolsado;

CAF: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para prazo total, até 18 anos, o spread mais recente é de 2, 0% a.a., sendo que nos primeiros 8 anos seria de 1,9%a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,85% do valor do financiamento; Comissão de compromisso de 0,35% a.a. do saldo não desembolsado; Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

Quanto aos financiadores internos, com aval da União, a carência é limitada a 12 meses e não há possibilidade de ressarcimento de despesas realizadas antes da assinatura do contrato de financiamento. Adicionalmente, ainda que os contratos com instituições nacionais exijam o cumprimento de critérios socioambientais, não há apoio técnico como aquele oferecido pelos grandes organismos multilaterais.

Além disso, o custo de operações internas aumentou devido a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança de 0, 5% do valor do financiamento a título de contrapartida ao aval da União.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivalem 11,46 % a.a.;

- O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,63% a.a. (atualmente 12,03% a.a.).

Por fim, apresentamos no anexo um quadro resumo para comparação das condições financeiras e prazos oferecidos pelos diversos agentes financeiros nacionais e internacionais.

Consta nos anexos uma tabela comparando as taxas de juros e condições das diversas instituições financeiras.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O PROJETO ARAS SÃO PAULO, por sua natureza de Projeto de apoio aos processos de gestão e de investimentos em reformas e atualização do parque tecnológico das unidades hospitalares nas RRAS da RMSP (RRAS de 01 a 06), RRAS 8 e RRAS 12, terá impacto social positivo para os usuários do SUS, tendo em vista a capacitação das equipes locais e a ampliação da oferta de serviços.

O atendimento a esta população se dará com atenção e consideração de suas especificidades culturais. Para o risco de privilégio indevido na seleção de beneficiários, serão construídas ferramentas com informações transparentes e objetivas, que focalizam o público a ser beneficiado, conforme critérios técnicos legalmente estabelecidos.

Público-alvo:

?Secretarias de Saúde, Estadual e Municipais, que poderão contar com recursos para estruturação e fortalecimento de sua capacidade gestora;

?Os serviços de saúde sob gestão estadual, que contarão com investimentos para melhorar sua capacidade produtiva, a qualidade dos atendimentos, a organização e potencialização da oferta de serviços à população;

?Os trabalhadores do Sistema Único de Saúde do estado de São Paulo, que poderão contar com maior qualificação e organização do processo de trabalho.

Beneficiários:

?A população SUS dependente do estado de São Paulo, com a melhoria do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde.

Também é importante destacar que apesar dos avanços das últimas dois décadas, ainda são grandes as barreiras de acesso ao SUS para certas populações, historicamente excluídas, como população negra (principalmente mulheres), quilombolas, indígenas e população privada de liberdade (prisões). Os investimentos do projeto, além de serem priorizados para as regiões mais pobres do Estado, são voltados para as populações mais pobres que residem nestas regiões, cerca de 1 milhão de famílias (pobres ou extremamente pobres) somente na Região Metropolitana de SP, uma das regiões beneficiadas pelo programa.

O projeto reforçará os compromissos do Estado de São Paulo quanto à melhoria de acesso à saúde das populações vulneráveis e minorias (Objetivo 5, Plano Estadual de Saúde- PES), por meio da expansão de serviços nas regiões com alta concentração de aldeias, quilombolas (DRS Sorocaba) e população preta/parda, principalmente jovens, concentrados na DRS Grande São Paulo. Ao mesmo tempo , expandirá exponencialmente os serviços de telemedicina para a população privada de liberdade, também alinhado com o mesmo objetivo do PES.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	113.000.000,00	1,00	113.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	230.000.000,00	1,00	230.000.000,00
Total:			343.000.000,00		343.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL:

O Projeto será executado e coordenado exclusivamente pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Unidade de Coordenação do Projeto vinculada ao Gabinete do Secretário ? GS, com a finalidade de gerenciar e acompanhar o andamento do Programa, não envolvendo nenhum outro órgão ou instituição para tanto.

Adicionalmente, o projeto envolverá a participação indireta de diversos atores como:

?Prestadores de Serviços de Saúde que prestam serviços para o SUS, participando da ampliação e qualificação da rede de atendimento;

?Departamentos Regionais de Saúde responsáveis pela coordenação e execução das ações do projeto em suas regiões;

?COSEMS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde) participando das discussões e decisões do projeto de Regionalização;

?Secretarias Municipais de Saúde colaborando na implementação das ações do projeto em nível local

Matriz de Responsabilidade:

Matriz RACI - Anexo XXVI

ARRANJO OPERACIONAL:

A execução estará a cargo da Secretaria de Estado da Saúde ? SES/SP. A SES/SP é o gestor estadual do SUS/SP.

Na coordenação e gerenciamento da execução do Projeto a SES/SP conta com equipe técnica própria, composta por profissionais com expertise em gestão, saúde, finanças, licitações e outras áreas relevantes para o projeto, com experiências exitosas na execução de programas financiados por organismos internacionais, como o Programa de Fortalecimento da Gestão na Saúde no estado de São Paulo, no período de 2014 à 2021, além de serviços de consultoria contratada especificamente para programas financiados, no apoio da execução e avaliação do Projeto.

A secretaria tem conhecimento das políticas de aquisição e salvaguardas socioambientais do BID, o que garante a execução do projeto de acordo com os padrões e requisitos do banco.

A Secretaria de Saúde foi criada com a denominação de Secretaria da Saúde Pública e da Assistência Social pelo Decreto nº 17.339 de 28/6/1947, que desvinculou os assuntos referentes à área de saúde dos de ensino. A denominação atual de Secretaria de Estado da Saúde foi estabelecida pelo Decreto n.º 52.182, de 16/7/1969.

No atual desenho do SUS/SP, resultado das diretrizes nacionais do sistema, a Secretaria de Estado da Saúde ? SES tem a responsabilidade geral de formulação e coordenação da política do SUS no Estado.

As funções da SES podem ser resumidas em 5 dimensões:

1.Manter a rede assistencial própria do Governo do Estado

São os serviços próprios estaduais de saúde, hospitalares ou ambulatoriais da administração direta, indireta (fundações e autarquias) e de Organizações Sociais de Saúde - OSS, que são referência regional, especializada ou de alta complexidade do sistema. Saliente-se que esta rede inclui grandes hospitais universitários, como os Hospitais de Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP, da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas ? UNICAMP e da Faculdade de Medicina da Universidade Paulista ? UNESP, o Instituto do Coração ? INCOR/USP, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

2.Gerir, planejar e regular a rede assistencial vinculada ao SUS

São os serviços de assistência médica de maior complexidade vinculados ao SUS, de caráter estadual ou regional, que permanecem sob gestão da SES (rede de Santas Casas e hospitais filantrópicos, Hospitais de Ensino, serviços especializados de oncologia, nefrologia, hemorrede, entre outros).

3.Manter os órgãos estaduais de apoio às ações da Secretaria de Saúde

São os institutos e fundações com funções específicas na saúde estadual, como a Fundação para o Remédio Popular (FURP), Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, Fundação Oncocentro (FOSP), Instituto Emílio Ribas, o Centro de Referência e Treinamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis ? DST/Aids, os institutos de pesquisa (Instituto Butantan, Adolfo Lutz, Instituto de Saúde, Instituto Pasteur, Instituto Lauro de Souza Lima).

4.Realizar, coordenar e planejar as ações de saúde coletiva no Estado

Estabelecer as normas estaduais e realizar ações de vigilância epidemiológica e sanitária, de combate aos vetores e outras ações de interesse para a saúde coletiva, por meio de seus órgãos centrais e regionais, como o Centro de Vigilância Epidemiológica ? CVE e o Centro de Vigilância Sanitária ? CVS.

5.Desenvolver ações de supervisão, capacitação, acompanhamento, avaliação e apoio aos sistemas de saúde municipais

Por meio de seus órgãos centrais e regionais (17 Departamentos Regionais de Saúde ? DRS) a SES participa dos colegiados regionais de saúde (em conjunto com os representantes municipais), prestando auxílio aos sistemas municipais de saúde e formulando estratégias de aperfeiçoamento do sistema.

A atual estrutura da SES/SP foi estabelecida por meio dos Decretos nº 49.343, de 24/01/2005, nº 51.433, de 28/12/2006, nº 51.434, de 28/12/2006 e nº 51.435, de 28/12/2006. ORGANOGRAMA SES- Anexo XXII

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	**9.000.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Modelos de governança inovadores	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA	1.500.000,00	0,00	300.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos	1.500.000,00	0,00	300.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	**185.000.000,00**	**0,00**	**37.000.000,00**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS	185.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS	36.924.519,71	0,00	7.384.903,94		
P - REformas das UNidades da Administração Direta	59.512.962,96	0,00	11.902.592,60		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS	50.565.752,72	0,00	10.113.150,54		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta	37.996.764,61	0,00	7.599.352,92		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL	**30.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**		
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE	30.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO	**6.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00		
P - UGP implantada	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**46.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**2.250.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.875.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	625.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	625.000,00		
P - Modelos de governança inovadores		0,00	625.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	375.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	375.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**46.249.999,99**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	46.249.999,99		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	9.231.129,92		
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	14.878.240,74		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	12.641.438,18		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	9.499.191,15		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**7.500.000,00**		
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	7.500.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	5.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	2.500.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**1.500.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	1.500.000,00		
P - UGP implantada		0,00	1.500.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**57.499.999,99**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**2.700.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	2.250.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	750.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	750.000,00		
P - Modelos de governança inovadores		0,00	750.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	450.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	450.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**55.500.000,01**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	55.500.000,01		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	11.077.355,92		
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	17.853.888,89		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	15.169.725,82		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	11.399.029,38		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**9.000.000,00**		

S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	9.000.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	6.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	3.000.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**1.800.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	1.800.000,00		
P - UGP implantada		0,00	1.800.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**69.000.000,01**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**1.350.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.125.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	375.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	375.000,00		
P - Modelos de governança inovadores		0,00	375.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	225.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	225.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**27.750.000,01**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	27.750.000,01		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	5.538.677,96		
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	8.926.944,44		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	7.584.862,91		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	5.699.514,70		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**4.500.000,00**		
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	4.500.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	3.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	1.500.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**900.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	900.000,00		
P - UGP implantada		0,00	900.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**34.500.000,01**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	750.000,00	0,00	7.500.000,00
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Modelos de governança inovadores		0,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**18.499.999,99**	**0,00**	**185.000.000,00**
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	18.499.999,99	0,00	185.000.000,00
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	3.692.451,97	0,00	36.924.519,71
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	5.951.296,29	0,00	59.512.962,96
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	5.056.575,27	0,00	50.565.752,72
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	3.799.676,46	0,00	37.996.764,61
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	3.000.000,00	0,00	30.000.000,00
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	2.000.000,00	0,00	20.000.000,00
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00
P - UGP implantada		0,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00
Total	**230.000.000,00**	**0,00**	**22.999.999,99**	**0,00**	**230.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Riscos

Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, projetos executivos, estimativas de custos, editais. Tais riscos serão mitigados com o recurso da experiência dos gestores do programa em contrato de financiamento internacional, com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento dos mesmos.

Outro risco poderia ser a dificuldade de coordenação entre os atores envolvidos, mas com baixa probabilidade de influencia na execução do Projeto, visto que as pactuações interfederativas e a discussão com prestadores tem sido muito bem sucedida na atual gestão.

Não haverá transferência de equipamentos para a gestão municipal, e o processo de regionalização em curso, já conta com a adesão de todos os Munícipios, através de um compromisso formalmente assinado por ocasião da constituição de Comitês Executivos de Governança em todas as RRAS. Documentos em anexo - Del. CIB 87/23 e Del. CIB 64/24

Com relação às obras de novos equipamentos, já estando previstos em Plano Plurianual, os terrenos são próprios do estado, não havendo a necessidade de desapropriação ou reassentamento de moradores, pois as áreas não são habitadas. Sua manutenção e custeio estão garantidos, não havendo nenhuma probabilidade de não se concretizar, visto que assim que se iniciam as obras é aberto o Processo para contratação da Organização Social parceira para a gestão da Unidade. (Atualização dos Processos relativos às construções em anexo)

Há o risco da transição do governo estadual, durante o período de execução do Projeto, e a mudança de prioridades do novo governo, porém o projeto estará em fase adiantada de execução, tendo a maioria das entregas já sido efetuadas.

Quadro de Riscos - Anexo XXVII

Atos Legais

O arcabouço legal para execução do Projeto está dado, visto que não haverá a participação de outras pastas, com a elaboração do escopo do projeto, ele será apresentado a todas as áreas da SES e municípios contemplados para execução do mesmo.

Uma vez que o Projeto esteja em andamento, poderão ser celebrados: Novos Termos de adesão com municípios; contratações de consultorias e contratações de empresas para as reformas previstas.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações estão vinculadas aos produtos listados nos componentes do projeto. Será necessária contratação de bens, consultorias e serviços. Está prevista, ainda, a contratação de profissionais para a viabilização da execução das ações, especialmente no interior, em interface com os municípios.

Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, projetos executivos, estimativas de custos, editais. Tais riscos serão mitigados com o recurso da experiência dos gestores do programa em contrato de financiamento internacional, com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento dos mesmos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Empreendimentos de infraestrutura, pela própria natureza e caráter sistêmico, podem provocar impactos no meio ambiente. No caso do Projeto ARAS, isto se aplica notadamente nos territórios onde acontecerão as construções dos novos hospitais.

O programa prevê um salto quanto à sustentabilidade ambiental dos equipamentos que serão construídos, reformados e ampliados. Todos contarão com métodos construtivos que promovam a resiliência frente aos eventos de cambio climático, eficiência hídrica e energética e gestão integrada dos resíduos sólidos em saude. Para tanto, estes serviços terão certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) que é um sistema de classificação internacionalmente reconhecido que avalia a sustentabilidade de edifícios e estruturas.

Ao mesmo tempo, ao buscar um futuro de qualidade para a população, a concepção do projeto implica a noção de sustentabilidade e a adoção de medidas de preservação do meio ambiente. Será adotado sistema alinhado com os padrões de desempenho previstos no Marco de Política Ambiental e Social (MPAS) do BID como alavanca para mitigação de riscos, melhor desempenho na execução dos projetos e melhores resultados ambientais e sociais, ao longo do ciclo de vida do projeto.

Para a variável ambiental, são especialmente relevantes as diretrizes relativas à avaliação e gestão de riscos e impactos sociais e ambientais e à conservação de

biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais, de modo apropriado à natureza, objetivos, necessidades, escala, prazo e recursos do programa.

Serão incorporadas as melhores práticas internacionais trazidas pelo BID às especificidades relacionadas à produção de infraestrutura pelo Programa, observandoos

elementos do marco legal e regulatório nacional e estadual aplicáveis, tais como:

a)Política Nacional do Meio Ambiente: com objetivos e forma de aplicação definidos

na Lei Complementar no 140/2011, Lei no 6.938/1981, Decreto no 99.274/1990, Resolução no 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e, no que respeita às penalidades aplicáveis às infrações ambientais, a Lei no 9.605, de 12/02/1998;

b)Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN no 4.945/2021: Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas à sua efetividade para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

As empresas contratadas para execução dos empreendimentos serão devidamente orientadas e fiscalizadas quanto ao cumprimento da legislação brasileira e paulista, bem como das salvaguardas ambientais do BID.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O PROJETO ARAS SÃO PAULO, por sua natureza de Projeto de apoio aos processos de gestão e de investimentos em reformas e atualização do parque tecnológico das unidades hospitalares nas RRAS da RMSP (RRAS de 01 a 06), RRAS 8 e RRAS 12, terá impacto social positivo para toda a população do Estado de São Paulo, especialmente aqueles que têm o SUS como única fonte de serviços de saúde, cerca de 27 milhões de pessoas (60% da população do Estado), tendo em vista a capacitação das equipes locais e a ampliação da oferta de serviços. Não se visualiza, a priori, impacto social adverso ou relacionado a conflito de interesses entre a administração pública e comunidades locais. A implementação das ações do Programa passará por acompanhamento permanente pelos conselhos estaduais e municipais de políticas públicas e garantias de direitos, implicando gestores públicos, técnicos da área, sociedade civil e beneficiários diretos.

Outros benefícios:

Geração de empregos diretos, nos serviços novos e ampliados. Em termos econômicos, considera-se que o setor saúde apresenta alta elasticidade de emprego. Um estudo (CV Deddeca, 2003) analisando o biênio de 2001-2002, mostra que a elasticidade gasto-emprego, considerando-se somente a ocupação do núcleo de saúde, foi estimada em 1,9, isto é, para cada ponto porcentual de aumento do gasto, a estimativa era de 1,9 ponto porcentual de incremento da ocupação.

O PROJETO ARAS SÃO PAULO contemplará as comunidades tradicionais com a ampliação da oferta de serviços e leitos, e os atendimentos proporcionados pela Saúde Digital, principalmente às populações vulneráveis, que residem em locais de difícil acesso (quilombos e aldeias e à população intramuros (Penitenciárias). O atendimento a esta população se dará com atenção e consideração de suas especificidades culturais. Para o risco de privilégio indevido na seleção de beneficiários, serão construídas ferramentas com informações transparentes e objetivas, que focalizam o público a ser beneficiado, conforme critérios técnicos legalmente estabelecidos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN